

La fiscalité du sucre en Europe

Formes, résultats et débats à l'échelle de l'Union européenne

Juillet 2026

Abstract

Douze États membres de l'Union européenne appliquent une forme de taxe sur les boissons sucrées (SSB). Les architectures diffèrent sensiblement : taxe forfaitaire sur le volume, taxe progressive sur la teneur en sucre, ou taxe élargie aux confiseries. Les études disponibles confirment un effet sur les prix (répercussion de 82 % en moyenne) et une baisse de consommation (élasticité estimée à $-1,00$ pour une taxe de 10 %), mais les preuves causales d'un bénéfice sanitaire restent insuffisantes aux taux européens actuels. La Commission européenne a publié en mai 2025 sa première étude comparative modélisant des scénarios d'harmonisation, mais la règle de l'unanimité prévue à l'article 113 du TFUE constitue un verrou politique structurel.

1 Introduction

La taxation des produits sucrés occupe une place croissante dans les débats de politique publique européenne. Entre impératifs de santé publique, objectifs de recettes fiscales et contraintes de gouvernance communautaire, le sujet cristallise des tensions qui ne se réduisent pas à un simple arbitrage santé-économie. Ce texte dresse un état des lieux des taxes existantes dans les États membres, présente les données disponibles sur leurs effets, et situe les positions des institutions, académiques et organisations de réflexion qui alimentent le débat.

Une note de méthode : plusieurs chiffres précis sur les taux nationaux n'ont pas résisté à une vérification contradictoire à partir des sources primaires. Le présent texte ne retient que les données confirmées ou issues directement de sources institutionnelles (Commission européenne, OMS, revues à comité de lecture).

2 Formes de taxation

Les taxes sur le sucre adoptées en Europe se déclinent en trois architectures principales, dont les effets économiques et comportementaux diffèrent sensiblement.

Taxe forfaitaire sur le volume. La forme la plus simple applique un montant fixe par litre, indépendamment de la teneur en sucre. Elle est facile à administrer et prévisible en termes de recettes, mais ne crée aucune incitation à reformuler les produits : une boisson à 3 g/100 ml est taxée autant qu'une boisson à 15 g/100 ml. La Belgique utilise ce modèle

depuis 2015 (étendu). Les recettes y sont stables mais systématiquement inférieures aux projections initiales : attendues à 250 millions d’euros en 2020, elles s’établissaient à environ 162 millions annuellement, et à 164,1 millions en 2021 (Ecorys et al., 2025).

Taxe progressive sur la teneur en sucre (*tiered tax*). Ce modèle applique des taux différents selon la concentration en sucre, par paliers. L’objectif premier est comportemental : rendre la reformulation économiquement rationnelle pour le fabricant. Plusieurs pays européens l’ont adopté. La France applique une taxe progressive depuis une réforme de 2018 (taxe initiale dès 2012) et recense environ 443 millions d’euros de recettes en 2023 (Tax Foundation, 2025) ; le Sénat a voté fin 2024 un barème encore plus glissant. L’Irlande a introduit sa *Sugar Sweetened Drinks Tax* en 2018 selon deux paliers. Le Royaume-Uni, bien qu’hors UE depuis 2020, offre la référence internationale la plus citée : le *Soft Drinks Industry Levy* (SDIL, avril 2018) fixe deux seuils à 5 et 8 g/100 ml.

Les six études pré-2020 qui ont examiné l’effet des taxes progressives sur la reformulation trouvaient toutes des preuves de réduction de la teneur en sucre dans les produits (Andreyeva et al., 2022). Les données post-2020 sont plus hétérogènes : une étude quasi-expérimentale portant sur quatre pays européens (Royaume-Uni, Irlande, France, Portugal) ne trouve un effet statistiquement significatif que pour le Royaume-Uni (Kaplan et al., 2025).

Taxe élargie aux produits sucrés. Certains pays ont dépassé le périmètre des seules boissons. La Hongrie est le cas le plus documenté : son *Public Health Product Tax* (2011, dit « taxe chips ») couvre les boissons sucrées, les confiseries, les snacks salés et certains condiments selon leur teneur en sucre, sel ou caféine. Ce modèle se rapproche d’une taxe de santé publique générale plus qu’une taxe SSB classique.

Table 1: États membres de l’UE taxant les boissons sucrées (2025)

Pays	Modèle	Introduction
Belgique	Forfaitaire (volume)	2015 (étendue)
Croatie	Accise (détails à confirmer)	–
Finlande	Accise sur boissons sucrées	2011
France	Progressive (teneur en sucre)	2012, réformée 2018
Hongrie	Élargie (boissons + confiserie)	2011
Irlande	Progressive (deux paliers)	2018
Lettonie	Accise	2020
Malte	À confirmer	–
Pays-Bas	Accise sur boissons sucrées	–
Pologne	SSB + édulcorants	2021
Portugal	Progressive	2017
Roumanie	Progressive (tiered)	2024

Note. Source : DG TAXUD (2025). Les structures précises pour Croatie, Malte et Pays-Bas n’ont pas pu être confirmées à partir de sources primaires. L’Italie a voté la mesure dans le budget 2021 mais ne l’avait pas appliquée à la date de rédaction.

3 Effets économiques et comportementaux

Répercussion sur les prix. Une méta-analyse de 86 études ([Andreyeva et al., 2022](#)) établit un taux de répercussion moyen de 82 % (IC 95 % : 66–98 %) : une taxe de 10 % génère en moyenne une hausse de prix d’environ 8,2 % pour le consommateur final. La répercussion varie selon le type de distributeur et le contexte national. Une étude américaine récente (Kaplan et al., *JAMA Health Forum*, 2024) trouve 92 % dans les villes concernées, cohérent avec la fourchette haute.

Élasticité et baisse de consommation. La méta-analyse de [Teng et al. \(2019\)](#) agrège 17 évaluations dans 6 pays et associe une taxe de 10 % à une baisse moyenne de consommation de 10,0 % (IC 95 % : –5,0 à –14,7 %), soit une élasticité-prix de –1,00 (IC : –0,50 à –1,47). D’autres méta-analyses produisent des estimations différentes : Afshin et al. trouvent –0,67 ; [Andreyeva et al. \(2022\)](#) rapportent –1,59. L’hétérogénéité statistique est élevée (I^2 souvent supérieur à 75 %), reflétant des différences réelles de contextes et de conception fiscale.

Recettes fiscales. Les projections de recettes sont systématiquement revues à la baisse. Deux mécanismes conjoints l’expliquent : la reformulation (qui réduit la base taxable dans les systèmes progressifs) et la substitution comportementale (les consommateurs migrent vers des boissons non taxées ou moins taxées). Le cas belge est documenté précisément : 162 millions d’euros annuels contre 250 millions projetés ([Ecorys et al., 2025](#)). La France fait exception relative avec 443 millions d’euros en 2023 ([Tax Foundation, 2025](#)), portés par une assiette plus large et plus d’une décennie d’existence.

Achats transfrontaliers. Dans les petits États très intégrés au marché unique, une part de la baisse de consommation domestique est compensée par des achats dans les pays voisins. [Ecorys et al. \(2025\)](#) illustrent l’effet sur le cas danois : une taxe de 0,20 €/litre réduirait les ventes domestiques de 24,8 millions de litres, mais 33,5 % de cet effet serait annulé par des achats en Allemagne. Les auteurs qualifient ce calcul d’*illustration indicative* fondée sur un coefficient marginalement significatif.

4 Effets sur la santé

La conclusion transversale de la littérature récente est que les taxes SSB réduisent les achats de boissons sucrées, mais que le lien causal avec les indicateurs de santé en aval (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires) reste difficile à établir empiriquement ([Narain et al., 2025](#)). Les effets sanitaires sont à long terme et diffus, les données nutritionnelles individuelles sont incomplètes, et les taux européens (généralement 1 à 5 %) sont inférieurs aux seuils modélisés dans les simulations (10–25 %).

L’étude de la Commission européenne ([Ecorys et al., 2025](#)) fournit néanmoins des estimations de simulation. Pour le scénario le plus ambitieux (taxe minimale UE à deux paliers, 10 et 15 euros par hectolitre, couvrant 25 États membres), le modèle prédit 6 079 nouveaux cas de cardiopathie ischémique évités et 12 226 nouveaux cas de diabète évités par an dans l’UE. Ces chiffres reposent sur une méthodologie IMC intermédiaire (apport

calorique, poids, maladie) et les données de la *Global Burden of Disease* ; ils constituent des estimations de simulation, non des résultats observés.

5 Le débat sur l’harmonisation européenne

En mai 2025, la Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD) a publié la première grande étude comparative sur les taxes de santé dans l’UE, réalisée par un consortium Ecorys/WIFO/Erasmus (Ecorys et al., 2025; DG TAXUD, 2025). C’est le premier document institutionnel à modéliser des scénarios d’harmonisation à l’échelle européenne. La Commission y conclut que l’harmonisation « pourrait contribuer à réduire les différences de taux et de structures et à promouvoir des conditions plus équitables pour les entreprises et les consommateurs, mais devrait tenir compte des différentes priorités de santé publique et des contextes fiscaux des États membres ».

La contrainte principale est juridique. Toute harmonisation fiscale relève de l’article 113 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, qui exige l’unanimité au Conseil. Un seul État peut bloquer une proposition, ce qui conduit la Commission à ne pouvoir qu’encourager, modéliser et recommander sans contraindre.

Les acteurs en présence sont polarisés. L’OMS Europe soutient les taxes SSB comme levier de santé publique (WHO Europe, 2022) et prépare pour septembre 2025 un *policy brief* sur les taxes alimentaires. Les associations industrielles, notamment UNESDA et Coldiretti en Italie, s’y opposent activement. Une étude publiée dans *Tobacco Control* (Gilmore et al., 2018) documente que les arguments et tactiques de lobbying du secteur alimentaire et des boissons reproduisent ceux de l’industrie du tabac : mise en doute de l’efficacité réglementaire et déplacement de la responsabilité vers les choix individuels.

6 Positions académiques et des organisations de réflexion

La littérature académique récente converge sur plusieurs résultats : les taxes SSB réduisent les achats à court terme, les taxes progressives favorisent la reformulation dans certains contextes, et la répercussion sur les prix est réelle et substantielle. En revanche, les données sur les effets de santé à long terme restent insuffisantes pour établir une causalité robuste.

La *Tax Foundation* (Tax Foundation, 2025) conclut que les données empiriques disponibles « ne montrent pas de réduction significative de l’IMC ou de l’obésité » pour les taxes effectivement appliquées en Europe, et souligne que les effets positifs sur la santé sont surtout documentés dans des modèles de simulation à des taux supérieurs à ceux en vigueur. Plusieurs points restent non résolus dans la littérature : l’Italie n’ayant pas encore appliqué sa taxe, ses effets demeurent inconnus ; les évaluations post-2020 en France, Irlande, Portugal et Pays-Bas ne montrent pas d’effets statistiquement significatifs sur la consommation ou la reformulation (Kaplan et al., 2025) ; l’impact distributif (caractère régressif des taxes SSB sur les ménages à faibles revenus) est documenté mais les dispositifs de compensation varient selon les pays et ne sont pas systématiquement évalués.

7 Conclusion

Douze États membres de l’UE taxent les boissons sucrées, selon des architectures très variées. Les effets sur les prix et la consommation sont réels et mesurables, mais modestes aux taux européens typiques. Les recettes sont systématiquement inférieures aux projections, car la reformulation et la substitution comportementale érodent la base taxable. Le débat sur l’harmonisation européenne est actif depuis la publication de l’étude DG TAXUD de mai 2025, mais la règle de l’unanimité et les divergences entre États membres constituent des obstacles structurels.

Sur le plan académique, il n’existe pas encore de preuves causales robustes liant les taxes SSB à des améliorations mesurables de la santé des populations aux taux actuellement pratiqués en Europe. Les modèles de simulation suggèrent des bénéfices substantiels à des taux suffisamment élevés, mais l’expérience européenne réelle est conduite à des niveaux trop faibles et depuis trop peu de temps pour que des effets cliniques soient statistiquement détectables.

References

- Andreyeva, T., Marple, K., Moore, T. E., et Powell, L. M. (2022). Evaluation of economic and health outcomes associated with food and beverage taxes and subsidies: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Network Open*, 5(6), e2214371. [PMC9161017](#)
- Commission européenne, Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (2025). *Study on health taxes from an EU perspective*. Publications Office of the European Union. [ec.europa.eu/taxud](#)
- Ecorys, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), et Erasmus University Rotterdam (2025). *Study on health taxes from an EU perspective: Final report and annexes*. DOI: [10.2778/2433087](#). [op.europa.eu](#)
- Gilmore, A. B., Savell, E., et Collin, J. (2018). Lobbying against sugar taxation in the European Union: analysing the arguments and tactics of stakeholders in the food and drink industries. *Tobacco Control*. [PMID 29974816](#)
- Kaplan, S. et al. (2025). Reformulation effects of tiered sugar-sweetened beverage taxes in four European countries: a quasi-experimental study. [PMC12142870](#)
- Narain, A. et al. (2025). Sugar-sweetened beverages: taxation evidence from seven European countries and recommendations for implementation in other EU regions. [PMID 39903599](#)
- Tax Foundation (2025). *Soda tax and sugar tax (SSB) analysis*. [taxfoundation.org](#)
- Teng, A. M., Jones, A. C., Mizdrak, A., Signal, L., MacGregor, G., et Neal, B. (2019). Impact of sugar-sweetened beverage taxes on purchases and dietary intake: systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 20(9), 1187–1204. [PMC9285619](#)
- Organisation mondiale de la santé, Bureau régional de l’Europe (2022). *Taxes on sugary drinks: why do it?* [WHO-EURO-2022-4781-44544-63081](#)